

MARCIA MARIA RIBEIRO

MEDICAMENTOS: HAS - Colesterol - Tiroide
 SINTOMAS/QUEIXAS: Sonolência
 BANHEIRO: 3x/4x
 HORA QUE ACORDA: 23:30
 HORA QUE DORME: 7hr.

PRÁTICA EXERCÍCIO

HORARIO DAS REFEIÇÕES

CAFE:

ALMOÇO:

LANCHE:

JANTA:

22 P= 8cmH₂O

02 m. de uso: 6h33'

22 IAH= 0,4 ev

Relata melhora do sonolência. fua

05/08 P= 8,0 cmH₂O

22 IAH= 0,57 ev

m. de uso: 6h23'

Relata estar se sentindo bem, descansar da, melhora a sonolência. fua
 não está indo mais ao banheiro.

24/08 P= 8,0

22 IAH= 0,4

A PA está ↓ isso já está melhorando.

↓ n.º de vezes ao banheiro.

melhora da sonolência. fua

27/09 P= 8,0 cmH₂O

22 IAH= 0,57 ev

m. de uso: 7h20

Oriento o uso de malha no reto fua

A PA= 13x8 mmHg.

29/11 P= 8cmH₂O

22 IAH= 0,4 ev

m. de uso: 6h51'

Bem adaptado, relata não estar se desligando do problema da mãe acamada. fua

24/01 P= 8cmH₂O

23 IAH= 0,4 ev

m. de uso: 6hr.

Bem adaptado. fua.

25/04
23

$P = 8 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 0,5 \text{ e/h}$
m. de uso: 5h40 (73%)

Relata melhora do quadro de ansiedade
porém não faz $\pm$, encaminhado p/ psiquiatra - fue

18/07/23

$P = 8 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 0,8 \text{ e/h}$
m. de uso: 7h25' (87%)
fuga: 4,9 l/min

n. na 1ª semana - dorme da mãe

Ansiedade $\rightarrow$ está tratando pela UBS
tomando medicamento.

19/08
23

$P = 8,0 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 0,6 \text{ e/h}$
m. de uso: 7h48'
Bem adapt. s/ queixas.

(esta da máso. remendada) fue

21/11
23

$P = 8,0 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 0,6 \text{ e/h}$
m. de uso: 7h7'
Fuga: 10,1 l/min.

Relata estar passando
bem o dia s/ queixas.
fue

20/02
24

$P = 8,0$
 $IAH = 0,5 \text{ e/h}$
m. de uso: 7h30'

fue

14/05
24

$P = 8 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 0,4 \text{ e/h}$
m. de uso: 7h19 min

Bem adaptada s/ queixas

Natasha

25/06
24

$P = 8 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 0,6 \text{ e/h}$
m. de uso: 7h21'
fuga: 6,2 l/m

Bem adaptada

Natasha

17/09/24

$P = 8 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 0,8 \text{ e/h}$
m. de uso: 6h48'
fuga: 8,7 l/m

Bem adaptada

s/ queixas

Natasha

17/12/24

$P = 8,0 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 0,5 \text{ e/h}$
m. de uso: 6h13'

Q alergia

Bem adaptada. (bombrino 1x) - fue.
PA controlada (às vezes).

18/03/25

P=8cm H₂O

IAH=0,5el/h

mdesup: 6h45'

puq: 2,9 l/m

Bem adaptada

Relata estar c/ a punção

alterada e c/ amarelado

Esta em tratamento

* Troco filtro

Natasha

24/06/25

P=8cm H₂O

IAH=0,5el/h

mdesup: 6h45'

puq: 2,7 l/m

* Troco filtro

Bem adaptada

Natasha

Dr. Mário Sérgio Leone Carregosa
Otorrinolaringologia

Paciente: **MARCIA MARIA RIBEIRO (64 anos)**

Convênio: **Aussel**

Relatorio medico.

*Paciente com indicação de uso de cpap na pressão titulada de 6,0
cm de h2o*

São José dos Campos, 16 de novembro de 2021

Dr. Mário Sérgio Leone Carregosa
Otorrinolaringologista
CRM 57.250

Dr. Mário Sérgio Leone Carregosa
CRM 57250

lms Santo Elza 1118
9924-7253
3921 - 1001

Av. Mal. Floriano Peixoto, 347- 4. And Sala 402 Centro Fone: (12) 3922-5011
Cep 12210-030 São José dos Campos / SP

Nome: MARCIA MARIA RIBEIRO

Data de Nascimento: 2-8-1957

IMC: 30,85

Sexo: Feminino

Data do exame: 24-09-2021

Peso: 84 kg

Altura: 1,65 m

Médico: DR. MÁRIO SÉRGIO LEONE

CARREGOSA

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia tipo "Split Night"

Exame realizado na noite de 24-09-2021, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 321,0. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 79,5 e 168,0 minutos. O tempo total de sono foi de 157,5, eficiência de 49,1% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 4,1%; estágio N2: 56,2%; estágio N3: 23,8%; sono REM: 15,9%. O índice de despertares foi de 3,2/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 18,3/hora, sendo elas 24 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 13 hipopnéias. A SpO2 média foi de 94% e mínima de 68%, permanecendo 3,3% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 55 - 81 bpm e NREM de 45 - 77 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (09), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 18,3/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=68%);
5. latências para o sono prolongadas;
6. número de despertares breves normal;
7. registro de ronco intenso durante o sono.

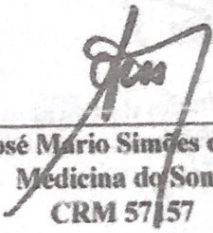
Exame polissonográfico Split-night evidenciando na parteda noite apneia obstrutiva do sono de grau moderado.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157

Nome: MARCIA MARIA RIBEIRO

Data de Nascimento: 2-8-1957

IMC: 30,85

Sexo: Feminino

Data do exame: 24-09-2021

Peso: 84 kg

Altura: 1,65 m

Médico: DR. MÁRIO SÉRGIO LEONE

CARREGOSA

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia tipo Split Night

Exame realizado na noite de 24-09-2021, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 181,5. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 43,0 e 56,5 minutos. O tempo total de sono foi de 126,5, eficiência de 69,7% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 1,6%; estágio N2: 28,5%; estágio N3: 24,1%; sono REM: 45,8%. O índice de despertares foi de 0,5/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 1,9/hora, sendo elas 0 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 4 hipopnéias. A SpO2 média foi de 95% e mínima de 89%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 52 - 86 bpm e NREM de 55 - 77 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (09), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM e do estágio N3 do sono NREM aumentada e porcentagem do estágio N2 do sono NREM diminuída;
3. latência para o sono aumentada e latência para o sono REM diminuída;
4. número de despertares breves normal;
5. registro de ronco intenso durante o sono.

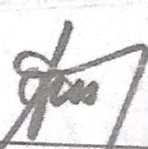
Exame polissonográfico Split-night, na segunda parte da noite para titulação de CPAP com melhor pressão terapêutica de 6 cmH2O.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57/57